PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 19 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

19.1 Conceitos

Sistema de Informação em Saúde (SIS) é o conjunto de componentes que atuam de forma integrada para **coletar, processar, armazenar, analisar e disseminar** dados e informações, com o objetivo de apoiar o planejamento, a tomada de decisões, o monitoramento e a avaliação das ações e serviços de saúde. O **DATASUS** (Departamento de Informação e Informática do SUS) é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos principais sistemas nacionais.

Diferença: **dado** é o registro bruto (ex.: número de nascidos vivos); **informação** é o dado processado e contextualizado (ex.: taxa de natalidade); **indicador** é a medida-síntese que reflete aspectos da saúde de uma população (ex.: coeficiente de mortalidade infantil).

A Lei nº 8.080/1990 prevê a organização de um **Sistema Nacional de Informações em Saúde**, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

19.2 Principais sistemas nacionais

Sistema	Documento-base	Finalidade
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade	**Declaração de Óbito (DO)**	Registra os óbitos; base para os indicadores de mortalidade. A DO é preenchida pelo **médico** em 3 vias
SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos	**Declaração de Nascido Vivo (DNV)**	Registra os nascimentos (peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, Apgar, consultas de pré-natal). A DNV pode ser preenchida por profissional de saúde (médico, enfermeiro, parteira) responsável pela assistência ao parto
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação	**Ficha de Notificação** e **Ficha de Investigação**	Registra doenças e agravos de notificação compulsória
SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares	**AIH** – Autorização de Internação Hospitalar	Registra as internações financiadas pelo SUS; base para o pagamento hospitalar
SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais	**BPA** (Boletim de Produção Ambulatorial) e **APAC** (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade)	Registra a produção ambulatorial
SI-PNI – Sistema de Informação do PNI	Registro do vacinado	Registra doses aplicadas, estoque e eventos adversos pós-vacinação, por indivíduo
SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	Marcadores de consumo alimentar e antropometria	Monitora o estado nutricional da população
SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica	Dados enviados pela **estratégia e-SUS APS** (Coleta de Dados Simplificada – **CDS** – e **Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC**)	Substituiu o **SIAB** (Sistema de Informação da Atenção Básica) a partir de 2013; registra as ações da atenção primária de forma individualizada (pelo CPF/CNS)
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Ficha cadastral do estabelecimento	Cadastra estabelecimentos, profissionais, leitos e equipamentos
SISCAN	Requisições de exames citopatológicos, histopatológicos e mamografias	Rastreamento do câncer do colo do útero e de mama (integrou o SISCOLO e o SISMAMA)
GAL – Gerenciador de Ambiente	Requisição de exames	Gerencia exames dos laboratórios

Laboratorial		de saúde pública (LACEN)
Notivisa	Notificação de incidentes e queixas técnicas	Vigilância sanitária (eventos adversos, queixas técnicas de produtos)

Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão SUS): identifica o usuário do SUS; atualmente, o **CPF** pode ser usado como identificador. A **Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)**, plataforma nacional de interoperabilidade, integra dados como vacinação e exames, disponíveis ao cidadão pelo aplicativo **Meu SUS Digital** (antigo Conecte SUS).

19.3 Indicadores mais cobrados

- **Coeficiente de mortalidade infantil** = (óbitos de menores de 1 ano ÷ nascidos vivos no ano) × 1.000 – usa dados do **SIM** (numerador) e do **SINASC** (denominador). Componentes: neonatal precoce (0 a 6 dias), neonatal tardia (7 a 27 dias) e pós-neonatal (28 dias a menos de 1 ano).
- **Razão de mortalidade materna** = (óbitos maternos ÷ nascidos vivos) × 100.000. Óbito materno: durante a gestação ou até **42 dias** após o término, por causa relacionada à gravidez (não acidental).
- **Coeficiente de natalidade** = (nascidos vivos ÷ população) × 1.000.
- **Coeficiente de incidência** e de **prevalência** (ver Assunto 10).
- **Cobertura vacinal** = (doses do esquema completo aplicadas ÷ população-alvo) × 100.
- **Proporção de nascidos vivos com baixo peso** (< 2.500 g).

19.4 Uso dos sistemas pela enfermagem

O técnico em enfermagem alimenta vários sistemas no dia a dia: registra as vacinas no **SI-PNI**/e-SUS, preenche fichas do **e-SUS APS** (atendimento, procedimentos, visitas), colabora no preenchimento da ficha de notificação do **SINAN** e registra procedimentos que geram produção no SIA. A qualidade do dado depende do registro **completo, correto e oportuno**: dados mal preenchidos geram indicadores incorretos e prejudicam o planejamento e o financiamento.

19.5 Proteção de dados

A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018)** classifica os dados de saúde como **dados pessoais sensíveis**, cujo tratamento exige cuidados especiais. É vedado compartilhar senhas de acesso aos sistemas, e o profissional responde pelo uso indevido de informações. O acesso deve ser restrito ao necessário para a assistência (ver Assunto 20 – sigilo profissional).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- SIM – Declaração de Óbito; SINASC – Declaração de Nascido Vivo; SINAN – Ficha de Notificação.
- SIH – AIH; SIA – BPA e APAC.
- SISAB/e-SUS APS substituiu o SIAB.
- SI-PNI – registro nominal de vacinação.
- CNES – cadastro de estabelecimentos e profissionais.
- Mortalidade infantil usa SIM + SINASC (× 1.000 nascidos vivos).
- Mortalidade materna até 42 dias (× 100.000 nascidos vivos).
- LGPD: dado de saúde é sensível.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"SIM morre, SINASC nasce, SINAN notifica"**.
- **"AIH interna, APAC é alta complexidade ambulatorial"**.
- **"SIAB morreu, nasceu o SISAB"** (com o e-SUS).
- **"Mortalidade infantil: morto do SIM sobre vivo do SINASC"**.
- **"Materna até 42 dias, por 100 mil"**.
- **"CNES conta prédios, gente e leitos"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

O sistema de informação cujo documento-base é a Declaração de Nascido Vivo é o:

(A) SIM.
(B) SINAN.
(C) SINASC.
(D) SIH/SUS.
(E) CNES.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o SIM usa a Declaração de Óbito.

B) Incorreta – o SINAN usa as fichas de notificação e investigação.

C) Correta – o SINASC registra os nascimentos a partir da DNV.

D) Incorreta – o SIH usa a Autorização de Internação Hospitalar.

E) Incorreta – o CNES cadastra estabelecimentos de saúde.

QUESTÃO 02

Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil de um município, utilizam-se dados dos sistemas:

(A) SINAN e SIH.
(B) SIM e SINASC.
(C) SIA e CNES.
(D) SI-PNI e SISVAN.
(E) SISAB e Notivisa.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – SINAN e SIH não fornecem óbitos e nascimentos de forma completa.

B) Correta – o numerador (óbitos de menores de 1 ano) vem do SIM e o denominador (nascidos vivos) do SINASC.

C) Incorreta – são sistemas de produção ambulatorial e cadastro.

D) Incorreta – são sistemas de vacinação e nutrição.

E) Incorreta – são sistemas da atenção básica e de vigilância sanitária.

QUESTÃO 03

O sistema que substituiu o SIAB e recebe os dados da atenção primária coletados por meio da estratégia e-SUS APS é o:

(A) SISAB.
(B) SIM.
(C) SINASC.
(D) SIA.
(E) GAL.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – o SISAB recebe os dados do e-SUS APS (CDS e PEC), de forma individualizada.

B) Incorreta – o SIM registra óbitos.

C) Incorreta – o SINASC registra nascimentos.

D) Incorreta – o SIA registra a produção ambulatorial para faturamento.

E) Incorreta – o GAL gerencia exames laboratoriais de saúde pública.

QUESTÃO 04

A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é o documento-base do:

(A) SINAN.
(B) SIH/SUS.
(C) SIA/SUS.
(D) SI-PNI.
(E) SISCAN.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o SINAN trabalha com fichas de notificação.

B) Correta – a AIH alimenta o Sistema de Informações Hospitalares.

C) Incorreta – o SIA usa BPA e APAC.

D) Incorreta – o SI-PNI registra a vacinação.

E) Incorreta – o SISCAN registra exames de rastreamento do câncer.

QUESTÃO 05

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), os dados referentes à saúde do paciente são classificados como:

(A) dados públicos, de livre divulgação.
(B) dados anonimizados por natureza.

(C) dados pessoais sensíveis.
(D) dados irrelevantes para a proteção legal.
(E) dados de uso exclusivo do Ministério da Saúde.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – dados de saúde não são de livre divulgação.

B) Incorreta – a anonimização é um processo, não uma característica natural do dado.

C) Correta – a LGPD considera dados de saúde como dados pessoais sensíveis.

D) Incorreta – esses dados têm proteção especial.

E) Incorreta – são tratados por diversos serviços, sempre com as garantias legais.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceito de SIS, dado, informação e indicador; DATASUS; SIM, SINASC, SINAN, SIH, SIA, SI-PNI, SISVAN, SISAB/e-SUS, CNES, SISCAN, GAL, Notivisa; CNS e RNDS; indicadores; papel da enfermagem; LGPD.

Quadro-resumo: DO → SIM; DNV → SINASC; ficha de notificação → SINAN; AIH → SIH; BPA/APAC → SIA; mortalidade infantil × 1.000 NV; materna × 100.000 NV.

Pegadinhas: SIAB como sistema vigente; confundir SIH com SIA; achar que a DO pode ser preenchida pela enfermagem.

Erros comuns: inverter numerador e denominador da mortalidade infantil; confundir SINAN com SINASC.